جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منيره حسنين شمس الدين سحالي
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الهرم **العنوان :** =
رقم البطاقة : 26706131700049 **رقم التليفون :** 01004980806 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 13-06-1967 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منيره حسنين شمس الدين سحالى
National ID: 26706131700049

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

منيره
حسنين شمس الدين سحتى

٤ ش التيوتى -المريوطية
الهرم - الجيزه

٢٦٧٠٦١٣١٧٠٠٠٤٩

JM1762106



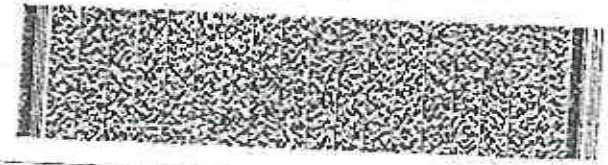
٢٠٢٢/٠٨ ٢٦٧٠٦١٣١٧٠٠٠٤٩

بدون عمل

انثى مسنمة متزوجة

ماهر حامد مجاهد ابو طالب

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٠٩





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

Name: منيره حسنين شمس الدين سحالي **MR. :** 3084	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 58-year-old individual with a history of estrogen-receptor positive, progesterone-receptor negative, HER2 + 3 breast cancer diagnosed in July 2020, treated with right breast-conserving surgery and axillary lymph node dissection, followed by adjuvant Herceptin, taxane-based chemotherapy (TaxterE), and postoperative radiation therapy. Adjuvant Herceptin was completed, and tamoxifen was administered from August 2020 until January 2023, after which the endocrine therapy was switched to an aromatase inhibitor (AI) as part of a multidisciplinary team plan for a five-year course beginning December 2025. The patient received zoledronic acid (Zometa) on 01/2026 and was prescribed femara (letrozole) with supportive therapy for three months.

The patient was prescribed femora plus supportive therapy for three months, with a scheduled follow-up in April 2026; imaging at that time demonstrated hepatomegaly on ultrasound while the serum markers were within normal limits.

The patient continued femora plus supportive therapy for three months, with the next clinic visit scheduled for 22 September 2026.

The patient presented for femora administration and supportive therapy; paracetamol was added for symptom control, and zoledronic acid was to be given after laboratory results were reviewed.

The patient was maintained on femora plus supportive therapy for three months, with the next clinic visit scheduled for 18 November 2026. The current plan is to continue femora and supportive care as previously outlined.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,



National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

جوستاف روسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

أسبوع مصر في صحة

MDT FORM 24 / 12 / 2021 G

Name	منيرة حسين	MRN	9761 2020
		ID	
Age	58	Phone	01004980806
Menopausal status	Post menopausal	Marital status	married
NRS SCORE		Family history	mot Aunt: Breast
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity	HTN		

Ciinical Data

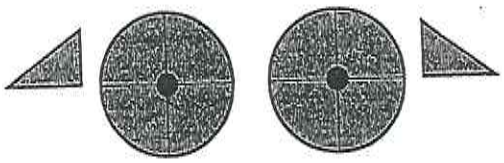
BX: IDC-GII

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
718	0/8	3+	>30%

Sonomammography:

Mets Workup:
CxR, PA US: free
Bone Sc: free

R L



TNM
2020: cT2 N2

Recommendations:
Rt breast IDC-GII since 2020 cT2 N2, ER 718, PR: 018
HER2: 3+, Ki67: 30%
Received NAC 3 AC, 3 Taxotere + Herceptin x2
→ Rt BCS + ALND 1/7(2020): ypT1mic, ypN0(1/8
→ Adj Herceptin, PORT, TAM (8/2020 → 11/2023) → ↑ ET, Postmenopaus

MDT OUTCOME & PLAN AI (11/2023 → now)
In view of Lung (M2) Met + Liver disease (Palliative)
→ Rft to AI (Anastrozole) for 6yrs (+) Zometa q 6

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE MDT_FORM]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry

Report Number: m706

Female	النوع	مدرية الضمان الصحي	
القاهرة	العنوان	53 Y	
05/02/2020 10:44	تاريخ استلام العينة		
09/02/2020 09:21	تاريخ التقرير	مسحة الفم ؟	
		مسحة الفم ؟	

Primary Sample

Paraffin Block

Test

ER &PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment

Technique

Sample recieved was treated by : CONFIRM anti ER (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody. CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (1E2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX
Sample recived was treated by : CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result

ER: moderate nuclear staining of 70 % of tumour cells
PR: No nuclear staining of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67 positive nuclear staining of > 30 % of tumour cells

Referal Lab

Comment

Conclusion

ER: POSITIVE (SCORE 7/8)
PR : NEGATIVE
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS > 30 %
(CORE BIOPSY)

Pathologist: دالیا ن رمزی

Lab Director: د.تريز [illegible]

19 El-sheikh Reran Street, Abeidaen, Cairo
Tel.(185)7946544 -7950096 Fax. (202)7946544
Mobile : 01144297292
website :http://www.healthlabs.net
email pathologycht@yahoo.com
facebook : قسم الجولوجي - المعامل المركزية للصحة

This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By Us

[illegible] 30 يوم من تاريخ التقرير

Page 1

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

بوابة التخصصية
السلام

Pathology Report

Name: منيرة حسين شمس الدين Age: 54 years.

Clinical data: Right breast cancer, post chemotherapy.

Specimen type: Right wide local excision & axillary clearance.

Date: 23/7/2020

Lab. Number: 1055 Hospital Number: 976/2020 مبادرة

Gross Description:

A sector of breast tissue; 11x9x3 cm, with attached skin ellipse; 9x8.5 cm and attached axilla; 7x6 cm, received enblock.
Serial cuts revealed wire guided rubbery to firm greyish white area measured; 2x2 cm, located (3.5, 3, 3, 6 & 3.2) cm from (upper, lower, medial, lateral & deep) margins respectively.
Dissection of axillary tissue revealed 18 nodules, up to; 1.5x1 cm.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared revealed breast tissue, showing hemorrhage and necrosis with microscopic infiltrating tumor tissue, formed of few groups of malignant ductal cells.
Surgical margins were free.
There were 18 reactive lymph nodes, with no metastatic deposits (0/18).

Diagnosis:

Right breast wide local excision & axillary clearance post chemotherapy;

- Microscopic remnants of invasive duct carcinoma (R1), with marked effect of therapy.
- Free surgical margins.
- Reactive lymph nodes (0/18), with no metastatic deposits.

Prof. Dr. Gamal Abdel-Aty *Prof. Dr. Essam Ayad*

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Monira Hasanain Shams Al Din Sahali	Date : 15/04/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 976/2020	Pat. ID: 18379

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Right breast conserving therapy

Report:

- Predominantly fatty parenchyma (ACR a)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse mild edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira I Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
15/04/2025 1:31 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Name: MOUNIRA HASANIN
Date: 02-06-2020

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Known case of breast cancer with indeterminate pulmonary nodules, compared to last study dated 22-02-2020

Findings:

- Regressive course of the right breast skin thickening with marked regression of the pathologically enlarged right axillary lymph nodes showing few residual subcentimetric nodes.
- Stationary size and number of the bilateral few scattered millimetric sub-pleural (2-3 mm) pulmonary micro-nodules.
- No hilar or mediastinal lymph nodes enlargement.
- Normal cardiac size.
- No pleural or pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Scanned upper abdomen shows fatty liver.

OPINION:

- **Regressive course of the right breast skin thickening with marked regression of the pathologically enlarged right axillary lymph nodes.**
- **Stationary size and number of the bilateral few scattered millimetric sub-pleural (2-3 mm) pulmonary micro-nodules likely of benign etiology .**

DR. Ibrahim Elsedawy.M.Sc,FEBR
Dr.m.gomaa,md

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name : Moneera Hasanen Shams al-Din
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 07-08-2025 09:54
Medical No. : 169990

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 58-year-old female, with right breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

DIAGNOSTIC CENTER

Call Center 19656

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

منيره
حسنين شمس الدين سحالى
٤ ش اللبينى -المربوطية
الهرم - الجيزه

٢٦٧٠٦١٣١٧٠٠٠٤٩

JM1762106



٢٦٧٠٦١٣١٧٠٠٠٤٩ ٢٠٢٢/٠٨

بدون عمل

انثى مسلمة متزوجة
ماهر حامد مجاهد ابو طالب
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٠٦

١



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]